

写给新手父母与照护者的母乳喂养读本

Breastfeeding 母乳喂养

从理想到现实的实操指南

循证知识 · 真实处境 · 可执行行动

编著 / BY zuihao.AI

01

母乳喂养的现实

02

开始与建立奶量

03

疼痛、堵奶与求助

04

工作、家庭与支持

05

安全边界与资源

适合孕晚期家庭、新手父母、照护者，用于建立判断框架，
也用于识别什么时候需要线下专业支持。

v0.1.0

2026 · 06

母乳喂养Breastfeeding

Guide to Home Care for Breastfeeding (Ages 0—5)

声明

- 本母乳喂养指南源自WHO、UNICEF、AAP等权威机构
- 本指南为指导父母母乳喂养的知识体系，非医学指引
- 本指南会随资料更新自动更新，以最近权威研究为准
- 用户对AI助手提供的信息有困惑时，建议多方核实

适用对象

- 孕产妇及5岁以内仍在进行母乳喂养的家庭
- 儿科、妇产科医务人员及推动母乳喂养的工作人员

目录

孕期 – 认知储备

生命最初1000天

母乳阻碍先读为快

初乳 – 宝宝的第一剂疫苗

初乳始于无：开奶之前有个空窗期 | 无营养吮吸 开奶秘诀：早接触、早吸吮和勤吸吮 初乳很少，一勺就饱（奶少，胃也小） 颜色很黄，高密度营养（营养 | 免疫） 干扰手段：母婴分离（不洗澡）、让娃多睡、怕娃渴饿、产妇需要休息（产后子痫前期、产后出血、子宫感染） 特殊情况：胎便污染羊水 | 早产儿 |

产后一周 – 纯母乳喂养的关键

24小时吃奶8—12次 第一周体重下降 胎便会从黑绿色，逐渐转为绿色、黄色 新生儿黄疸很常见 含乳：含乳姿势、C型手势、乳头破损疼痛、乳房胀痛、乳腺炎（催乳）

0-6个月纯母乳喂养

母乳：0-6 | 6-14 | 不要奶瓶奶嘴 | 乳头混淆 按需喂养 | 定奶 | 密集吃奶 | 宝宝是否吃饱 热天能否喂水 月子文化：减少探望；帮忙照顾；饮食下奶 洗澡 | 按摩 补维生素D（钙 | VA | DHA | 锌 | 碘） 返岗 | 背奶 | 勺喂注意事项

母乳谣言：“没奶水 = 妈妈体虚、气血不足、血化成奶” 母乳谣言：靠食补才能下奶，不吃补品就没奶 胸小没有奶 产后出汗多是气血太虚 妈妈容易疲劳、乏力就是气血亏，所以产不出奶，要长期静养少带娃 喂奶损耗妈妈气血，喂久了妈妈会变老、体虚、落下病根 断奶后乳房下垂是喂奶掏空气血，气血恢复不了 奶水带血丝是气血亏虚、血混入奶，要立刻停喂补血 月子不能喝水 补气血中药

母乳喂养

生病及用药 | 小儿推拿 儿童生长曲线 母乳谣言：6个月后母乳没营养 母乳喂养宝宝的腹泻和便秘问题 宝宝夜奶严重 戒夜奶与自然离乳 乳糖不耐 肠道菌群 不能母乳喂养的情况 | 宝宝禁忌与妈妈禁忌

辅食添加

扯蛋的辅食信号 辅食的添加时间：不早于6个月，不迟于9个月 宝宝的第一口辅食 过敏 | 不过敏的辅食白名单 挑食 | 精细喂养与换牙 | 辅食补铁 | 贫血 重视重金属（砷、铅、汞、水） 辅食与营养不良 营养素与添加剂（母乳之外都是辅食）

人工喂养

奶粉的历史 奶粉如何选择 冲泡奶粉的水温 奶粉的营销和危害

生命最初1000天：奠定一生身心健康的基石

第一部分，震撼父母的数据

有一个数据，所有父母都应该知道。《中国心血管健康与疾病报告2023》的数据，2021年心血管病分别占农村、城市死因的48.98%和47.35%，几乎接近一半。可能很多人不知何谓心脑血管疾病，其实就是心梗、中风、猝死背后的真正疾病，大家总喜欢把原因归结为学习压力大，工作强度高，加班、熬夜、过劳。虽然这种疾病和成年后的饮食、运动、压力、睡眠有关，但越来越多研究提醒我们：一个人对心脑血管疾病的易感性，并不是到了四五十岁才突然出现的。它的地基，可能早在生命最初1000天就已经建好。

也许有人会说：“孩子刚出生，怎么就和几十年后的心血管病、糖尿病、肥胖联系到一起了？”这正是很多父母最容易忽略的地方。我们总以为，健康是长大以后的事情。孩子小时候，只要不生病、不发烧、体重长得快，看起来白白胖胖，就觉得养得不错。等到一个人中年以后出现肥胖、高血压、糖尿病、脂肪肝，甚至心梗、中风，我们才开始回头找原因：是不是吃得太油？是不是运动太少？是不是压力太大？是不是经常熬夜？

这些原因当然重要。但它们往往只是推倒身体的最后一块多米诺骨牌。真正的地基、第一块多米诺骨牌，可能藏在宝宝还只是个胚胎的时候。

生命最初1000天，是从怀孕开始，到孩子两岁为止。孕期大约280天，出生后大约720天。加起来这1000天，孩子的身体不是在简单长大，而是在建立一生的代谢系统、免疫系统、心血管系统和大脑发育基础。

一个孩子在妈妈肚子里的营养环境，出生后的喂养方式，婴儿期的生长速度，早期的肠道菌群、免疫系统和代谢系统，都会参与塑造这个孩子未来怎样利用能量、怎样储存脂肪、怎样调节血糖、怎样面对炎症和压力。

这个观点听上去很惊人，但它不是育儿焦虑，也不是商业广告。它来自过去几十年里，一个越来越重要的科学领域：健康和疾病的发育起源。

它想回答的问题很简单：为什么有些人长大后更容易肥胖？为什么有些人更容易患高血压、糖尿病和心血管疾病？为什么同样的饮食、同样的生活方式，有些人的身体更能承受，有些人却更早出现问题？

科学家逐渐发现，答案不能只从成年后的生活习惯里找。还要回到生命刚开始的时候。

而这个领域最重要的起点之一，就是著名的巴克假说。

第二部分，健康和疾病的发育起源

巴克假说

20世纪80年代初，David Barker 及其他研究者注意到一个看似矛盾的现象：虽然随着国家整体富裕程度提高，心血管疾病的总体发生率会上升，但在一个富裕国家内部，最贫困的居民反而承受着最高的患病率。

他和其他研究者通过一系列研究提出：如果胎儿时期处在不良环境中，而成年后又处在食物充足的环境里，这种组合可能会成为成年慢性病的“配方”。这一观点后来被称为 Barker 假说。是指出生体重和其他婴儿期指标，与成年疾病发生率之间的联系。

1944年冬天和1945年春天，在一次铁路罢工之后，德国占领当局限制了荷兰西部地区的食物配给，包括阿姆斯特丹在内。当地居民，包括孕妇，每天只能获得低至 400—800 千卡的食物。饥荒影响了各个社会阶层，战后又紧接着进入了逐渐富裕的时期。

发表于1976年的“荷兰饥饿冬天”研究，虽然源于一场悲剧，却几乎构成了一项设计完美的人类自然实验，用来观察宫内营养剥夺对后续成年健康的影响。这项研究为一个不断发展的领域提供了关键支持和基础洞见，这个领域就是“健康和疾病的发育起源”，英文叫 DOHaD（多哈）。

出生体重

“荷兰饥饿冬天”研究的一个重要发现是：那些会影响成年健康的孕期经历，并不一定会反映在出生体重上。

如果母亲在妊娠中晚期经历饥荒，婴儿的出生体重往往会明显降低。可是，如果母亲只是在妊娠早期经历饥荒，孩子出生时的体重可能完全正常。问题在于，这些出生体重正常的孩子，长大后反而更容易肥胖；他们成年后的肥胖率，不仅高于二战前和二战后出生的人，也高于那些在妊娠中晚期经历饥荒的人。

这说明，出生体重虽然是观察胎儿营养状况最容易获得的指标，但它并不是后来成年疾病的直接原因，也不能完整反映所有会影响成年健康的孕期风险。

换句话说，一个孩子出生时体重正常，并不意味着胎儿时期没有受到影响。宫内营养不足，即使没有造成出生体重下降，也可能在身体内部留下长期影响，改变孩子成年后的代谢和肥胖风险。后来在啮齿动物和绵羊等动物研究中，也观察到了类似现象。

发育的关键时期

“荷兰饥饿冬天”研究的另一个重要启示是：孕期营养不足发生在什么时候，非常关键。

如果饥荒发生在妊娠晚期，孩子出生时通常体重较低，并且一生中体型都偏小；他们成年后的肥胖率反而低于饥荒前后出生的人。

但如果饥荒发生在妊娠早期，情况就不同了。这些孩子出生体重可能正常，但成年后更容易出现肥胖、血脂异常和心血管疾病风险升高。相比之下，肾功能下降的相关指标，则更多出现在妊娠中期经历饥荒的人身上。

“发育存在关键窗口期”这个概念，在 DOHaD 理论出现之前就已经存在。在动物实验中，科学家可以比较容易地验证不同发育阶段受到影响后会发生什么。但在人类身上，不可能为了研究而故意让孕妇在某个阶段经历饥饿。因此，大多数流行病学研究很难清楚回答“哪个孕期阶段最关键”这个问题。

也正因为如此，“荷兰饥饿冬天”研究格外重要。它虽然来自一场悲剧，却像一次自然发生的人类实验，让我们看到：孕期某个短暂阶段的饥饿经历，如何影响孩子几十年后的健康。

营养错配

发生在1958–1961年的中国大饥荒，不仅是人类历史上一次惨烈的社会经济灾难，也为生命科学、流行病学和人口经济学提供了一个规模空前的“自然实验”场域。这场饥荒造成了约1700万至3000万非正常死亡，被视为人类记录史上死亡人数最多的单次饥荒事件。它影响范围极广，不同地区受灾程度差异很大。所以研究人员可以比较不同出生年份、不同地区、不同暴露阶段的人群，观察他们成年后的健康差异。

而饥荒的幸存者在几十年后又经历了中国快速的经济发展和饮食变化。也就是说，很多人生命早期经历的是匮乏，成年后却进入了食物越来越充足、热量越来越高、生活方式越来越现代化的环境。这种前后环境的巨大反差，正好对应了巴克假说里非常重要的一个概念：营养错配。

北京大学公共卫生学院（马冠生教授团队）与哈佛大学等机构合作的研究被公认为该领域的奠基性经典。其中最具代表性的研究是2011年发表于糖尿病顶级期刊《Diabetes Care》的实证论文：《生命早期暴露于中国大饥荒与成年期代谢综合征风险》。该研究最重要的贡献是提出了“早期营养匮乏 + 成年期营养过剩”的“双重打击”证据。研究发现，在严重受灾地区，胎儿期暴露于饥荒的个体患高血糖的风险是非暴露者的3.92倍；但如果该个体成年后采取了西方饮食模式（高油脂、高热量），其高血糖风险会剧增至7.63倍。

心血管系统对生命早期营养不足非常敏感

很多关于中国大饥荒的研究发现，胎儿期或婴儿期经历饥荒的人，成年后更容易出现代谢问题，比如血糖异常、2型糖尿病、肥胖、血脂异常和代谢综合征。

在肥胖和代谢综合征方面，研究还发现了明显的性别差异。女性受到的影响往往更明显，尤其是在成年后的BMI、肥胖风险和代谢综合征方面。这可能和生物学差异有关，也可能和当时资源分配、儿童照护、社会偏好等因素有关。简单说，在极端匮乏时期，不同孩子实际得到的食物和照顾可能并不一样，这些差异也会被身体长期记录下来。

中国大饥荒研究还支持了一个重要判断：心血管系统对生命早期营养不足非常敏感。特别是在妊娠早期，如果胎儿经历营养不足，成年后高血压、冠心病、中风等风险可能会增加。原因之一是，妊娠早期正是肾脏、血管和心血管系统打基础的时候。比如肾单位的数量基本在出生前就已经确定，如果胎儿期发育受限，出生后肾单位数量偏少，成年后每个肾单位就要承担更大的工作压力，时间久了，就更容易和高血压、肾脏负担加重联系在一起。

随着这一代人逐渐进入老年，研究者还开始关注认知功能。已有研究提示，生命早期经历饥荒的人，晚年可能更容易出现记忆力、执行功能、视觉空间能力等方面的下降。更深入的一层，是表观遗传。过去我们以为，遗传主要看DNA序列。但现在我们知道，营养是基因的“开关”。中国大饥荒相关研究发现，胎儿期饥荒暴露可能和一些代谢、胰岛素功能、血脂调节相关基因的甲基化变化有关。简单说，饥荒并没有改写DNA本身，却可能改变了身体读取这些基因的方式。这样的变化，有些甚至可以在几十年后仍然被检测到。

错配的适应

胎儿期营养不足是否会导致成年慢性病，不只取决于胎儿期发生了什么，也取决于出生后进入了怎样的环境。

越来越多的研究也证明，最危险的情况可能不是“胎儿期营养不足”本身，而是胎儿期经历匮乏，出生后又迅速进入营养充足环境。后来的许多动物研究也证实，不良宫内环境之后的“追赶生长”，在这种长期健康风险中扮演着重要角色。

正如课程最开始的死亡数据，我们真的不知道是明天先到，还是无常先到。年纪轻轻的名人猝死频繁地登上热搜，大多数逝者没有意识的几分钟之后自己和最爱的人就将阴阳两隔。也有人因为感受到身体的不适，开始积极的自救，例如某高考志愿规划名师中午还在跑步机上疯狂锻炼，看似是死神好不眷顾其与命运抗争的努力，其实是他努力的方向错了，记住，营养是基因表达的“开关”，对于癌症和心脑血管等慢性疾病的逆转，改变饮食是首要的选择，没有改变饮食的运动、健身都是徒劳的。

第三部分，营养是基因表现的“开关”

前面讲了一堆宏达的研究，现在讲一个接地气的数字。1994—1995年，研究人员测量了1570名3—6岁儿童的血压。这其实是关于母乳喂养宝妈什么时候恢复生理期的研究，研究案例分别生活在中国成都、危地马拉、智利、尼日利亚和瑞典。这些儿童全部为孕周超过37周出生，出生体重都超过2.5千克。在每个国家，儿童当前体重越高，血压也越高。另一个数据是出生时体型越小，收缩压越高。例如在智利，在调整当前体重后：出生体重每减少1千克，收缩压升高4.9毫米汞柱；出生身高每减少1厘米，收缩压升高1毫米汞柱；出生头围每减少1厘米，收缩压升高1.3毫米汞柱。这些关联不受孕周长短影响。在这些来自中国、中美洲和南美洲的样本中，儿童血压升高与出生时身体比例整体缩小有关。这种比例性缩小通常源于整个妊娠期生长受限。而高血压是卒中的一个已知危险因素，因此，备孕和改善孕期的营养与健康，可能对预防发展中国家的心脑血管疾病具有重要意义。

那么，生命最初1000天是指哪一段时间？是从怀孕开始，整个孕期有280天，到宝宝出生后两岁，又有约720天，合计就是生命最初1000天。孕期营养影响胎儿编程，出生后喂养继续影响孩子的代谢、免疫、肠道菌群和肥胖风险。世界卫生组织（WHO）强调这是人一生中生长发育最快、奠定健康基础的“关键窗口期”。如果人生是一栋高楼，这1000天就是决定高楼长久屹立或不幸坍塌的地基。

如今，生命最初1000天的概念正被商家疯狂盗用，用来宣传婴儿配方奶粉、米粉和各种补充剂。世界卫生组织也一再警告，配方粉使儿童易患感染病、哮喘、脑膜炎、肥胖和糖尿病。但依然有大量的父母缺乏最基本的营养和母乳喂养常识，据权威医学杂志《柳叶刀》的研究，如果提升母乳喂养率，每年可以挽救82万名5岁以下儿童的生命。2019年，上海调查发现超过半数中小学生过敏。如果宝宝出生后吃的第一口奶不是母乳，那伴随他们的可能就是终身过敏体质。

所以，母乳喂养从来不只是“吃不吃奶”的问题。它是孩子出生后的720天里，父母最常参与、最容易被误导、也最能影响孩子长期健康的关键行动。

不止是身体的健康，从出生到3岁的1000天，是潜意识形成和性格的“关键窗口期”。监狱中有75%的罪犯是4次以上的惯犯，他们基本都属于无情型人格，大都又源于生命最初1000天的忽视、冷漠或虐待，具体会在性格培养的课程中详解。

给您的建议

当您完成生命最初1000天的学习，我不知您是否会思考，我能为自己和孩子做些什么？给您三条建议：

1、提前备孕，戒烟限酒，让自己的BMI数值处于19-23区间，既不太瘦，又给孕期留下增长空间。仅仅自己不吸烟是不够的，努力戒掉二手烟，尽量避免宝宝生活的空间有三手烟，烟草是宝宝哮喘的诱因之一。2、完成营养健康课程学习，通过多食用豆类、粗粮、蔬菜和水果，减少动物性食物来排毒，完成身体质量的蜕变。这个建议和公众普遍的常识有冲突，是因为大众不爱学习，却又活在资本精心营造的信息茧房中。3、生命最初1000天不是宿命论，但它深刻影响我们的每日生活和一生的身心健康。最初的营养错配毁掉的是成年后身体的健康，最初的忽视、虐待会迫使孩子用一生治愈童年。而给孩子一个好的人生开端，首要是自己得是一个稳定、理性和爱学习的人。

母乳喂养不亚于万里长征，准备好了吗？

第一部分，孤立无援的母乳喂养大环境

仅有5%的新生儿第一口奶吃的是母乳

有一群医学院的学生，在医院询问孕妇，准备如何喂养自己的宝宝，结果有95%的孕妇想要母乳喂养宝宝。等这群孕妇产后出院时，学生问宝宝出生后的第一口奶吃的是何时，仅有5%的产妇报告自己的宝宝第一口奶吃的是母乳，数据搞好翻转了。

为什么？因为第一次产检时，胎儿就已经被资本盯上了，商人拿出真金白银获取母婴的信息，并不是为了做慈善，而是将母婴视为自己的提款机，为了利益最大化，抢夺新生儿的第一口奶就成为资本与父母博弈的最前沿和最重要的战场。

因诺琴蒂宣言与全球共识

为了对抗日益疯狂的资本掠夺，1989年，世界卫生组织（WHO）和联合国儿童基金会（UNICEF）首次联合提出“纯母乳喂养”的倡议，倡导婴儿在出生后前6个月应完全由母乳喂养。

1990年8月，在意大利佛罗伦萨的因诺琴蒂中心，WHO与UNICEF正式签署并发布了具有里程碑意义的《因诺琴蒂宣言》。这份宣言明确将“6个月纯母乳喂养”确立为全球公共卫生目标，呼吁各国政府制定政策、培训医护人员、改善母婴照护体系，以全面支持母乳喂养。

《因诺琴蒂宣言》的主要内容和核心要点：主要目标：母乳喂养是婴儿获得最佳营养、健康和发展的自然方式，并呼吁全球采取行动，确保所有婴儿在生命最初阶段得到充分的母乳喂养支持。

核心内容 婴儿喂养的理想标准 所有婴儿在出生后的前6个月应完全采用纯母乳喂养（即不添加任何其他食物或液体，包括水，除非有医学需要）。在6个月后，应在继续母乳喂养的同时，逐步引入适当的辅食，母乳喂养可持续至2岁或更长时间。

保护、促进和支持母乳喂养的行动 国家层面：各国政府应制定政策和法律，保护母乳喂养，例如落实《国际母乳代用品销售守则》（1981年通过），限制奶粉的营销。医疗机构：所有产科医院和保健机构应采取措施支持母亲在婴儿出生后立即开始母乳喂养，并避免不必要的奶粉喂养。后来有了专门的认证，例如爱婴医院。社会支持：通过教育和宣传，提高公众对母乳喂养益处的认识，消除文化和社会障碍。

全球合作与承诺 呼吁国际组织、政府、NGO和社区共同努力，创建一个支持母乳喂养的环境。强调需要监测和评估母乳喂养的实施情况，确保政策有效执行。

世界卫生组织（World Health Organization，简称WHO）是联合国下属的专门机构，负责制定全球卫生目标和战略，为各国提供技术指导和建议。联合国儿童基金会（United Nations Children's Fund，简称UNICEF）致力于在全球范围内促进和维护儿童生存权、发展权、受保护权和参与权的组织。

在世界卫生组织和联合国儿童基金会发起“纯母乳喂养”倡议之前，各国医疗机构使用的儿童生长指南并非完全基于母乳喂养儿童的数据，其中夹杂了大量人工喂养儿童的样本，导致标准存在偏差。为了为全球提供更科学、精准的儿童生长数据，世界卫生组织于1997年至2003年间联合联合国儿童基金会，在巴西、加拿大、

加纳、印度、挪威和阿曼六国，筛选出8440名健康、接受母乳喂养的儿童进行系统随访，直至5岁。研究表明，纯母乳喂养的婴儿在生长发育、免疫力及智力发展方面具有明显优势，尤其在预防呼吸道感染和腹泻等常见传染病方面更为突出。纯母乳喂养不仅显著降低婴儿期疾病的发生率，还有效减少早期死亡风险。

抱歉，政府并未实质支持父母

守护母乳喂养最重要的力量是政府，看一个政府是守护婴童福祉，还是只在乎资本利益，不要听它说什么，要看它做什么。

国际母乳代用品销售守则

《国际母乳代用品销售守则》是世界卫生组织（WHO）于1981年5月21日由世界卫生大会通过的国际健康政策框架，旨在通过保护和促进母乳喂养，确保婴儿获得安全和充足的营养，并规范母乳代用品（如婴儿配方奶粉、辅食、喂养瓶和奶嘴）的营销。其核心目标是防止母亲因不当营销而放弃母乳喂养，并确保替代品在必要时的安全使用。

《国际母乳代用品销售守则》具体内容包括：

禁止行为：禁止向孕妇、哺乳期母亲或公众提供免费或低成本的母乳代用品样品、促销材料或礼品。**医疗机构的限制：**禁止在医疗保健设施内展示或推广母乳代用品，包括禁止提供免费样品、使用医务人员进行推广或举办相关活动。**标签要求：**要求母乳代用品的标签上必须包含准确信息，例如母乳喂养的优越性、配方奶粉的正确使用方法、潜在健康风险（如病原体污染）和不当使用的危害。标签不得包含误导性图片或文字，如暗示母乳代用品优于母乳或鼓励瓶喂。**信息教育材料：**要求所有与婴儿和幼儿喂养相关的教育材料必须突出母乳喂养的好处，禁止使用（奶粉）行业提供的材料。**监测和执行：**建议成员国通过立法将守则纳入国家法律，并建立独立、透明的监测机制，明确责任主体和违规处罚措施。

中国的实施情况分析

《国际母乳代用品销售守则》是为了守护母婴的利益，但在我国其不具有任何法律约束力。父母们但凡留意，都会发现它的每一条守则都被我们按在地上使劲摩擦，我们的感受有时并不精准，世界卫生组织和联合国儿童基金会也会对各成员国的实施情况进行检查。

中国确实实施了《国际母乳代用品销售守则》，但实施程度有限，存在显著的差距。根据2022年WHO和UNICEF联合发布的《母乳代用品营销：国际守则的国家实施状况报告2022》，中国的实施情况如下：

法律基础与评分，满分100分，我们得分32分。2015年的《中华人民共和国广告法》是法律层面执行《守则》的唯一证据。

“最适合中国宝宝体质”、“专利配方”、“最接近母乳”这些耳熟能详的违法广告遍地都是，我们是如何获得了32分。

得分细分为以下类别：范围（得分8）仅覆盖12个月以内的婴儿母乳代用品，不包括辅食和喂养瓶及奶嘴。

监测和执行（得分0）明确了负责监测的主体，但未定义违规行为的制裁措施，也未要求监测独立于商业影响且透明。

信息/教育材料（得分3）所有要求的内容均未完全包括，包括：母乳喂养的好处 母亲营养的重要性 部分瓶喂的负面影响 放弃母乳喂养的决定难以逆转 配方奶粉的正确使用方法 使用母乳代用品的含义和风险 不当喂养/使用的健康危害 内在污染风险 不得提及特定品牌产品 不得使用理想化母乳代用品的图片或文字 社会和经济影响 禁止行业提供材料

向公众的推广（得分10）广告：禁止（但监测和执行行为0）。向公众提供样品：未禁止。销售点促销设备：未禁止。与母亲的直接接触：未禁止。向孕妇和母亲赠送礼品：未禁止。

医疗保健设施内的推广（得分0）总体禁止推广：未禁止。展示相关产品：未禁止。展示标牌/海报：允许。分发制造商材料：未禁止。使用设施举办活动/宣传：未禁止。制造商使用医务人员：未禁止。

与医务人员的互动（得分0）总体禁止礼物/诱因：未禁止。财务/物质诱因：未禁止。奖学金、考察、研究资助、会议参与：未禁止。要求披露：未要求。免费/低成本供应：未禁止。设备/服务捐赠：未禁止。捐赠中提及特定产品：未禁止。产品样品：未禁止。产品信息限制：未限制。会议赞助：未禁止。

标签要求（得分11）婴儿配方奶粉：禁止内容：均未禁止，包括营养/健康声明、暗示6个月前使用、贬低母乳喂养、与母乳比较、推荐瓶喂、专业人士背书等。要求信息：均未包括，包括“重要提示”、母乳喂养优越性声明、仅在医务人员建议下使用、准备说明、健康危害警告、病原体风险警告、理想化使用图片、推荐年龄、2岁以上继续母乳喂养的重要性、6个月前不推荐辅食等。后续配方奶粉：与婴儿配方奶粉类似，均未禁止相关内容或包括要求信息。

尽管有一部《广告法》措施，但监管为0，作为父母您作何感想？研究显示中国存在广泛的母乳代用品营销违规行为。例如，一项多国研究（包括中国、孟加拉国、墨西哥、摩洛哥、尼日利亚、南非、英国、越南）记录了制造商的营销活动对父母喂养决策的显著影响。政府的不作为和默许制造商违法营销，长期的代价就是国民的整体素质越来越低，一个连婴童福祉都不顾的政府，何谈食品安全。

抱歉，医疗机构是抢夺初乳的急先锋

由世界卫生组织（WHO）和联合国儿童基金会（UNICEF）于1991年联合发起的一项全球性项目，旨在通过改善医疗机构的服务和实践，保护、促进和支持母乳喂养。这一倡议是1990年《因诺琴蒂宣言》的直接延续和具体实施，目标是确保所有母亲和婴儿在出生后能够获得最佳的喂养支持。

核心内容：十项措施 母婴友好医院倡议（Baby-Friendly Hospital Initiative, 简称BFHI）BFHI的核心是“促进母乳喂养成功的十项措施”，所有希望获得“母婴友好医院”认证的医疗机构必须遵守这些标准：1、制定书面政策：建立支持母乳喂养的明确政策，并传达给所有医护人员。2、培训员工：为医护人员提供必要的培训，使其具备支持母乳喂养的知识和技能。3、产前教育：向孕妇及其家人宣传母乳喂养的益处和方法。4、早期接触：帮助母亲在婴儿出生后半小时内开始母乳喂养。5、哺乳指导：指导母亲如何正确哺乳，并维持乳汁分泌，即使母婴暂时分离。6、纯母乳喂养：除非有医学指征，不给新生儿喂食除母乳外的任何食物或饮品。7、母婴同室：让母亲和婴儿24小时同处一室，促进亲密接触和按需哺乳。8、按需哺乳：鼓励根据婴儿需求随时哺乳，而不是按固定时间表。9、避免奶嘴：不给母乳喂养的婴儿使用奶嘴或人工奶头，以免干扰哺乳。10、后续支持：建立母乳喂养支持网络，确保母亲出院后能获得社区或专业帮助。

实施与认证 医院需经过自我评估、外部评审和实地检查，证明其符合“十项措施”，才能被授予“母婴友好医院”称号。截至目前，全球已有超过150个国家的20,000多家医疗机构获得认证。

在中国，BFHI于1992年引入，第一批“母婴友好医院”于1990年代中期获得认证。截至近年，全国已有数千家医院参与这一倡议，尤其在城市地区推广较广。但是，我们也看到国外的著名乳业公司因为贿赂医院受到处罚，央视曾揭露新生儿第一口吃什么奶粉，取决于宝宝被安排在哪一层，每一层的奶粉品牌不一样。

推动母婴友好医院变革

伴随出生率下降，医院为争抢客户也是费尽心机。育儿网校将基于孕产妇的反馈，在各城市给医疗机构打分，引导孕产妇选择支持母乳喂养的医院。希望每一位孕产妇都能积极报告产检医院和自己信息泄露情况，在宝宝出生后，及时报告医院干扰母乳喂养的情况。

抱歉，很多育儿平台并不真正希望你学会母乳喂养

今天的母婴行业，有一个很少被公开说破的现实：很多育儿平台、母婴社区和母婴博主，表面上都在说“母乳喂养好”，但它们真正赖以生存的商业收入，往往来自配方奶粉、婴儿米粉和各种补充剂。

这就决定了一个很尴尬的结果：它们可以温和地支持母乳喂养，但很难真心地指导你母乳喂养。因为母乳喂养的家庭，基本上远离了奶粉消费、焦虑消费和服务消费。可在商业逻辑里，一个持续焦虑、不断提问、反复购买的妈妈，才是更有价值的用户。

所以，很多父母进入育儿群之后会发现，群里最热闹的不是科学喂养，而是广告、推荐、团购和经验争吵。真正坚持母乳喂养、愿意分享系统知识的妈妈，很快会被踢出群。因为她们说出的真相，既可能影响别人的生意，也可能刺痛一些已经被迫放弃母乳喂养的妈妈。

久而久之，很多育儿群就变成了信息茧房。妈妈们在里面互相安慰，互相模仿，互相强化焦虑，却很难真正获得可靠、系统、可执行的科学喂养支持。

这也是育儿网校存在的原因。 育儿网校不是要把母乳喂养变成妈妈一个人的责任，也不是要用母乳喂养去审判任何妈妈。恰恰相反，我们要做的是把母乳喂养从“妈妈一个人的孤军奋战”，变成“整个家庭共同参与的科学养育”。

因为母乳喂养从来不是妈妈一个人的事。 它需要爸爸理解，需要长辈支持，需要家庭形成共识。 很多家庭背负房贷、车贷的压力，老人并不懂得生命早期陪伴的重要性，只是单纯想帮忙分担照顾孩子，让宝妈“早点断奶去上班”。但生命最初几年，孩子需要的远远不只是吃饱和安全。

他需要稳定的回应，需要熟悉的气味，需要温柔的身体接触，需要在一次次被抱起、被安抚、被理解中，建立对世界最初的信任。

早期陪伴影响安全感，安全感影响性格，性格影响命运，而孩子的命运，最终会反过来影响整个家庭的福祉。

所以，育儿网校要做的，不只是教妈妈怎么喂奶。 我们真正要做的，是帮助一个家庭看见： 母乳喂养不是小事，早期陪伴不是闲事，生命最初1000天不是可有可无的事。 这是孩子人生的开端。 共识是一个家庭和睦相处的关键所在。

第二部分，为什么你应该坚持

母乳喂养不是“可有可无的加分项”，而是对宝宝、妈妈、家庭和社会都具有可量化收益的基础健康投资。世界卫生组织指出，母乳是婴儿的理想食物，安全、清洁，并含有可预防多种常见儿童疾病的抗体。

从高质量证据看，母乳喂养最明确、最稳定的收益，首先体现在感染与住院风险下降。Lancet 系列综述显示，在 6 个月内，与不母乳喂养相比，纯母乳喂养与感染性死亡显著下降相关；在 6—23 个月，任何母乳喂养都与感染性死亡风险下降相关。母乳喂养还与腹泻、下呼吸道感染、急性中耳炎住院和发病风险下降相关。

对母亲而言，母乳喂养不是单向“付出”。系统综述和荟萃分析显示，较长的总哺乳时长与更低的乳腺癌、卵巢癌、2 型糖尿病、高血压和部分心血管结局风险相关；同时，哺乳过程中的催产素释放还可帮助子宫收缩，减少产后出血。

对家庭而言，母乳喂养的现实收益很“接地气”：更少的配方奶支出、较低的疾病相关医疗费用、更少因孩子生病而误工、在停电、出行、灾害或供应波动时更强的喂养韧性。中国的相关成本研究估算，家庭每年为商业配方奶直接支出的费用超过 70 亿美元；而在国际经济学模型里，提高母乳喂养率可显著减少家庭与医保体系的医疗和非医疗成本。

一个同样重要的事实：坚持母乳喂养，不是妈妈一个人的“意志力测验”。Lancet 2023 系列、WHO“成功母乳喂养十项措施”以及中国相关政策都提示，家庭支持、医疗机构支持、返岗环境和商业营销压力，都会实质性影响母乳喂养是否成功。换句话说，很多“坚持不下去”，并不是因为妈妈不够努力，而是因为支持系统不够好，所以，妈妈要成为最早的学习者。

母乳喂养对宝宝的好处

母乳的“量身定制”与无可替代性

中国母婴家庭面对的是非常具体的环境阻力。UNICEF 中国报告显示，97% 的孕妇和母亲在过去一年中见过或听过配方奶广告；研究提示，广告和推广会提高前 6 个月使用配方奶的概率，而返岗工作是引入配方奶的重要时间点之一。

这也是为什么，谈“坚持母乳喂养”，不能只谈“母乳有多好”，还必须谈系统支持：家人的态度、医院的流程、出院后的咨询、工作场所是否允许哺乳或挤奶、以及商业营销是否在削弱母亲信心。Lancet 2023 系列明确指出，婴幼儿喂养不仅是个人选择问题，也是社会、政策和商业力量共同塑造的结果。

对宝宝来说，母乳喂养最确定的优势，是它同时具备营养、免疫和发育支持三重价值。WHO 明确指出，母乳能提供婴儿最初几个月所需的全部能量和营养；在出生后第一年的后半年，母乳仍可满足一半或一半以上的营养需求；在第二年仍可满足约三分之一的营养需求。更重要的是，母乳不仅是“热量和蛋白质”，还是含抗体和多种生物活性成分的活体食物。

最强的证据来自感染性疾病。Lancet 2016 系列纳入多项系统综述后显示，在 6 个月内，与“无母乳喂养”相比，纯母乳喂养与感染性死亡显著下降相关。母乳喂养对婴幼儿早期生存有实打实的保护作用。

在常见疾病上，保护效应同样清楚。母乳喂养与 6 个月内腹泻发病风险下降相关；5 岁内因腹泻住院风险下降相关；2 岁内下呼吸道感染发病或患病风险下降相关。Lancet 总结称，约一半腹泻发作和三分之一呼吸道感染可因母乳喂养而避免，而腹泻和呼吸道感染住院风险下降更大。

对于很多父母最常见的“耳朵发炎、反复感冒、老跑医院”这类困扰，证据也相当一致。Lancet 系列中的系统综述显示，2 岁以内更多母乳喂养与急性中耳炎风险下降相关。

在早产儿或低出生体重儿中，人乳的意义更大。针对早产儿的系统综述显示，与配方喂养相比，供体人乳可显著降低坏死性小肠结肠炎风险；而 AAP 相关综述也指出，在早产和低出生体重儿中，配方奶相对母亲自有乳增加坏死性小肠结肠炎风险。也就是说，对脆弱宝宝而言，“有没有人乳”本身就是重要的风险分界线。

母乳喂养的好处不仅停留在“少生病”，还延伸到更远期的代谢健康。Lancet 的 113 项研究荟萃分析显示，更长的母乳喂养与超重/肥胖几率下降相关。

发育层面，母乳喂养与认知表现的关系，是很多父母关心但又常被争论的话题。仅看观察性研究，Lancet 综述显示，母乳喂养与儿童和青少年 IQ 平均提高约 3.44 分相关；即便控制母亲智力后，差异仍约 2.62 分。更有说服力的是 PROBIT 这项以“促进更长、更纯的母乳喂养”为目标的集群随机试验：干预组儿童在 6.5 岁时的 verbal IQ 比对照组高 7.5 分，阅读与写作的教师评分也更高。

还有一些益处虽不像感染保护那样“铁板钉钉”，但值得知道。系统综述提示，母乳喂养与儿童白血病发病下降 19% 相关；而关于婴儿猝死综合征，个体参与者水平的荟萃分析显示，至少持续 2 个月的母乳喂养与 SIDS 风险约减半相关。

如果把这些证据放在一起看，对父母最实际的结论是：**坚持母乳喂养的价值，不只在“更天然”这类泛泛表述，而在于它能真实地减少早期生病、住院和脆弱期风险，并给远期体重管理和认知表现带来平均意义上的优势。**

母乳喂养对妈妈的益处

很多母亲的体验是：“喂奶好像全在为孩子付出。”但从医学证据看，母乳喂养对母亲并不是单向消耗，而更像是一种帮助身体完成产后恢复与长期代谢重置的生理过程。美国妇产科医师学会指出，哺乳触发催产素释放，能促进子宫收缩，并可能减少产后出血。

从中长期看，证据最扎实的是肿瘤保护作用。Lancet 2016 系列指出，每增加 12 个月累计母乳喂养时间，浸润性乳腺癌发生率约下降 4.3%；关于卵巢癌，更长时间母乳喂养与更低风险相关，整体荟萃分析约下降 30%。

另一组非常重要的收益，来自代谢和心血管健康。JAMA Network Open 的系统综述与荟萃分析显示，累计哺乳超过 12 个月与母亲糖尿病风险下降 30% 相关；高血压风险下降 13%。对许多父母来说，这意味着母乳喂养不仅关乎宝宝的前 6 个月，也与妈妈 10 年、20 年后的健康有关。

更广义的心血管结局也有类似趋势。2022 年的系统综述与荟萃分析涉及 100 多万经产妇，结果显示，与从未母乳喂养者相比，曾经母乳喂养的女性总体心血管疾病风险下降约 11%，冠心病下降 14%，卒中下降 12%，心血管死亡下降 17%。这类证据主要来自前瞻性观察研究，不能完全排除混杂，但方向相当一致。

关于产后月经恢复和生育间隔，证据同样明确。系统综述显示，尤其是纯母乳或以母乳为主的喂养方式，与更长的泌乳性闭经相关。

母亲们也常问：母乳喂养能不能帮助情绪恢复？这里需要讲得更谨慎。系统综述提示，较短的母乳喂养时长与更高的产后抑郁风险相关。

因此，对妈妈来说，把这段生理窗口变成对自己未来健康的投资。与此同时，如果出现明显疼痛、严重情绪问题、睡眠剥夺或喂养失败感，尽早求助和调整，同样是负责任的做法。

母乳喂养对家庭的好处

Alive & Thrive 发布的《中国不母乳喂养的代价》指出，中国家庭每年仅为“经济型商业配方奶”支付的直接支出就超过 71 亿美元。这还没有算上因感染、住院、误工、认知损失等带来的间接成本。对于普通家庭来说，母乳喂养并不意味着“零成本”，因为仍可能需要吸奶器、储奶袋、哺乳内衣、咨询服务和时间投入；但若只比较婴儿口粮和相关疾病支出，母乳喂养通常能明显降低现金压力。

第二笔账，是“孩子少生病，父母少请假”。美国农业部关于 WIC 的经济研究指出，提高母乳喂养率可以减少家庭医疗费用和父母因照顾患病婴儿而错过工作的损失。其逻辑并不复杂：如果母乳喂养能降低腹泻、呼吸道感染、中耳炎等常见病，那么家庭就会少一些夜间急诊、少一些药物和请假损失。

第三个家庭收益，是喂养韧性。WHO 和 UNICEF 都强调，母乳安全、清洁，不依赖额外水源和冲调条件；在灾害、停电、出行、物流波动或家庭临时混乱时，母乳喂养尤其重要。当无法母乳喂养时，配方奶当然是必要替代选择，但 UNICEF 同时强调，配方喂养在紧急状态下对供给、卫生和安全条件要求更高。

第四个现实好处，是家庭内部更容易形成一致的照护节律。这不是说母乳喂养一定比配方喂养“轻松”，而是说，一旦喂养建立起来，家庭通常能更清楚地围绕按需喂养、睡眠安排、返岗挤奶、出门储奶等问题形成分工。家庭成员要从营养、心理等多方面支持母亲实现母乳喂养；也就是说，母乳喂养从来都不是妈妈一个人的工作，而是家庭协作能力的一次现实考验。

坚持母乳喂养的收益，往往不是一天两天里感受到的“高大上健康优势”，而是日常生活里非常具体的少花钱、少跑医院、少打乱节奏、少在紧急情况下手忙脚乱。

母乳喂养对社会的好处

当母乳喂养率提高，受益的不只是某一个家庭，而是整个公共卫生系统。UNICEF 与 Lancet 系列估算，如果全球母乳喂养水平达到更优水平，每年可挽救超过 82 万名 5 岁以下儿童生命，其中大多数是 6 个月以下婴儿；同时还能减少大量与乳腺癌相关的女性死亡。

社会收益首先体现为公共卫生负担下降。更多母乳喂养意味着更少腹泻、肺炎、下呼吸道感染、中耳炎、坏死性小肠结肠炎等病例，也意味着更少门诊、住院、抗菌药物使用和家庭照护负担。Lancet 系列强调，母乳喂养在低收入国家对儿童死亡的保护作用尤其大，但在高收入国家，母乳喂养也能降低如坏死性小肠结肠炎和婴儿猝死等严重结局。

社会收益还体现在人力资本。母乳喂养与更高的平均认知测试成绩相关，PROBIT 和巴西 30 年出生队列都支持其对认知和教育成就的长期影响。Lancet 进一步指出，母乳喂养对收入的影响，很大一部分可由 IQ 的提

升解释。换句话说，母乳喂养并不仅仅是“健康议题”，也是教育和经济发展议题。

经济学上，“不母乳喂养”的代价非常大。UNICEF 中国报告引用的全球估算显示，不足的母乳喂养每年造成约 3020 亿美元经济损失；而在中国，相关模型估算“不母乳喂养”的总经济损失高达数百亿美元量级，约占国民总收入的相当比例。

环境层面，母乳喂养在减缓全球变暖、土地利用和富营养化等方面都表现优异。虽然这类研究的结果会受母亲饮食结构、但总体上母乳喂养的碳足迹更低。

最后，母乳喂养还是一个制度质量问题。WHO 的《母乳代用品国际销售守则》之所以存在，就是因为社会已经认识到：如果婴儿喂养决策被商业营销、弱支持和错误信息主导，那么真正被牺牲的，是妇女、儿童和家庭的健康权。母乳喂养本是最自然的喂养方式，但如今成为一项艰难的全球公共卫生政策。中国的奶粉市场规模一度接近3000亿，最疯狂时，美国市场上50%的奶粉都被我们代购走了。Lancet 2023 系列则进一步指出，商业配方奶行业不仅影响消费，还会影响政策、科学传播和公众对喂养“正常值”的理解。

第三部分，成为母乳喂养的倡导者

很多妈妈在刚开始母乳喂养时，都会经历一段非常孤独的时期。孩子一哭，身边人就说：“是不是奶不够？”孩子黄疸，别人说：“先停母乳吧。”孩子晚上频繁醒，别人说：“奶粉更顶饿。”妈妈乳头疼、堵奶、睡不好、情绪崩溃的时候，真正能理解的人并不多。所以，母乳喂养从来不只是一个喂养方式的问题，它更像是一场认知、技术、家庭支持和社会环境的综合考验。

很多妈妈不是不想喂母乳，而是在最需要支持的时候，没有人真正帮她一把。这也是为什么，我们希望育儿网校是一个母乳喂养支持系统。

我们希望每一个曾经受益的妈妈，将来都能成为另一个妈妈的支持者。你今天学到的知识，明天可能会帮助一个正在崩溃的新手妈妈坚持下来。你今天的一句鼓励，可能会让一个孩子多吃一天母乳。而这一天，对孩子来说，可能就是免疫力、肠道菌群、亲密关系和生命早期安全感的一部分。

在中国，真正坚定支持母乳喂养的人，其实并不算多。不是因为母乳不好，而是因为很多妈妈一旦转向奶粉喂养，就很难再公开强调母乳的价值。因为她们会担心：“我说母乳好，是不是就在否定自己？”“我没有坚持下来，是不是说明我不是一个好妈妈？”“我现在孩子吃奶粉，我还有资格支持母乳吗？”所以，很多人选择沉默。但我们必须说清楚：支持母乳，不等于批评没能母乳的妈妈。一个妈妈最后选择了奶粉，背后可能有太多复杂原因：没有人指导、家人不支持、医生建议不清楚、产后太痛苦、工作环境不允许，甚至只是因为她在最困难的时候没有遇到正确的人。

真正应该被反思的，不是某一个妈妈的选择。真正应该被改变的，是这个社会没有给妈妈足够好的支持。所以，育儿网校要做的，不是制造妈妈之间的对立，而是让更多妈妈在一开始就少走弯路。我们要让母乳喂养从“靠意志硬撑”，变成“有知识、有方法、有支持、有伙伴”的科学养育行动。

还有一件事，就是全职妈妈，是这个社会里最容易被收割的一群人。保险、直销、微商、各种所谓副业项目，甚至一些杀猪盘诈骗，都特别喜欢盯上全职妈妈。因为她们有时间焦虑，有收入焦虑，有价值感焦虑。很多人告诉她们：“宝妈在家也能轻松月入过万。”“学个证书，时间自由，高薪就业。”“做母婴行业，既能带娃又能赚钱。”但现实往往是，宝妈们交了培训费、囤了货、消耗了信任，最后一无所获。所谓零基础“高薪催乳师”，就是收割培训费，如果你在育儿网校帮助下成功母乳喂养，你就会知道“催乳师”是个多么扯淡的名字，按摩乳房更是造成乳腺炎的最简单方法。育儿网校不希望全职妈妈继续在这些陷阱里被消耗。我们希望做一件更踏实的事：让真正相信科学养育、真正推动母乳喂养、真正帮助其他妈妈的人，能够从这件正确的事情中获得尊重，也获得实际回报。

育儿网校是一个AI驱动的健康、养育平台，我们的使命是把纯母乳喂养率提升至80%，要达成这一目标，需要足够多的孕产妇掌握母乳喂养支持，自己成功之后，主动去推动更多人学习。为了实现这一目标，育儿网校将成为一个全用户持股平台，每推荐一位孕产妇加入平台，就会获得一股分红股。育儿网校会从营收中拿出一定比例的利润，按持股比例分给用户。这是一场健康和养育变革，您既是见证者，也是推动者，更是受

益者。拥有高级勋章的用户，也会成为育儿网校的城市代言人，您如果从事和母婴相关的业务，会获得资源的倾斜。远离各种欺诈，从推动母乳喂养中受益。